Клинические рекомендации

Отит средний острый

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.0** — Острый средний серозный отит **H65.1** — Другие острые негнойные средние отиты **H66.0** — Острый гнойный средний отит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/314_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 2

2. Клиника и классификация 2

2.1 Определения 2

2.2 Стадии 2

2.3 Тяжесть 3

2.4 Клиническая картина 3

2.5 Возбудитель и выбор антибиотика 3

3. Диагностика 3

3.1 Маркеры бактериального воспаления 4

4. Лечение 4

4.1 Боль и температура 4

4.2 Когда нужен антибиотик 4

4.3 Выбор антибиотика 5

4.4 Суточные дозы 5

4.5 Местная и вспомогательная терапия 6

4.6 Хирургия 6

5. После острого периода и госпитализация 7

6. Источник и актуальность 7

6.1 Неточности в самом тексте КР 7

1. Главное

- Острый средний отит — воспаление всех трёх отделов среднего уха: барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой трубы. Проявляется болью в ухе, температурой, снижением слуха, иногда гноетечением.
- Диагноз ставят, когда одновременно есть внезапное начало, воспаление барабанной перепонки и признаки выпота: выбухание или сниженная подвижность перепонки при пневмоотоскопии или тимпанометрии. Внезапная оторея при исключённом наружном отите тоже подтверждает диагноз.
- Детям до 2 лет с признаками острого среднего отита антибиотик назначают всегда. В любом возрасте он нужен при гнойной форме, при симптомах дольше 72 часов, рецидивирующем отите, отягощающей сопутствующей патологии и если повторно осмотреть пациента нельзя.
- Препарат первой линии — амоксициллин. Если за 3 дня эффекта нет, его меняют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим. Курс — 7–10 дней.
- Для обезболивания назначают НПВП или парацетамол; ушные капли с лидокаином и феназоном можно только при целой барабанной перепонке.
- Через 3–4 недели пациента осматривают повторно с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы не пропустить экссудативный средний отит.

2. Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определения

Острый средний отит — воспаление всех трёх отделов среднего уха (барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой трубы) с одним или несколькими симптомами: болью в ухе, повышением температуры, снижением слуха, иногда гноетечением. Поражается только слизистая оболочка.

Рецидивирующим отит называют, если за 6 месяцев было 3 эпизода и больше или за 12 месяцев — 4 и больше.

Затянувшимся отит называют, если симптомы воспаления среднего уха сохраняются 3–12 месяцев после одного или двух курсов антибиотиков.

У детей бывают возбуждение, раздражительность, рвота и понос. Обычно болезнь длится не дольше трёх недель.

2.2 Стадии

1) острый евстахеит; 2) катаральное воспаление; 3) доперфоративная стадия гнойного воспаления; 4) постперфоративная стадия гнойного воспаления; 5) репаративная стадия.

В катаральной стадии барабанная перепонка гиперемирована и утолщена, опознавательные знаки едва видны или не видны.

В гнойной стадии боль резко усиливается, температура поднимается до фебрильной, перепонка ярко-красная и выбухает, опознавательных знаков нет; возможна перфорация.

В постперфоративной стадии через перфорацию в слуховой проход поступает гной.

В репаративной стадии жалоб почти нет, цвет и толщина перепонки восстанавливаются, перфорация чаще закрывается рубцом, но слизистая среднего уха ещё не восстановилась.

2.3 Тяжесть

Лёгкое течение	Тяжёлое течение
Нет осложнений	Интратемпоральные или внутричерепные осложнения
Нет выбухания барабанной перепонки	Выраженное выбухание барабанной перепонки
Недолгая боль в ухе, хорошо снимается лекарствами	Выраженная боль (у маленьких детей — изменения поведения), плохо или не снимается лекарствами
Общее состояние не изменено: сон, еда, активность в норме	Общее состояние изменено
Нормальная температура или субфебрилитет не более 3 дней	Субфебрилитет более 3 дней или температура выше 38,0 °C

2.4 Клиническая картина

У детей старше 2 лет главный признак — внезапная боль в ухе на фоне воспаления барабанной перепонки (гиперемия, выбухание, сниженная подвижность при пневмоотоскопии), а после перфорации — оторея. У маленьких детей важнее выбухание перепонки и поведение: беспокойство, отказ от еды, ребёнок дёргает и трёт ухо.

Взрослые чаще жалуются на заложенность уха, аутофонию и шум в ухе.

Тугоухость кондуктивная; сенсоневральный компонент присоединяется редко.

2.5 Возбудитель и выбор антибиотика

Возбудителя иногда можно предположить по клинике: отит с конъюнктивитом чаще вызывает H. influenzae; стремительное начало с лихорадкой, спонтанной перфорацией и симптомами со стороны дыхательных путей — S. pyogenes; нарастающая боль, температура и спонтанная перфорация — S. pneumoniae.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз ставят, когда одновременно есть три признака: внезапное начало, воспаление барабанной перепонки (гиперемия, инфильтрация) и выпот в барабанной полости (выбухание, сниженная подвижность при пневмоотоскопии или тимпанометрии). Внезапная оторея при исключённом наружном отите тоже подтверждает диагноз.

Каждого пациента должен осмотреть оториноларинголог.

Если реактивных изменений барабанной перепонки нет, её подвижность оценивают при пневматической отоскопии.

Тональную аудиометрию проводят при затяжном течении (дольше 10 дней), рецидивирующем отите или чтобы исключить нейросенсорную тугоухость.

Развёрнутый общий анализ крови делают всем пациентам.

Прокальцитонин определяют при подозрении на тяжёлое течение или в сложных случаях, чтобы подтвердить бактериальную природу отита.

3.1 Маркеры бактериального воспаления

Показатель	Катаральный отит	Гнойный отит
Лейкоциты <10 / 10–15 / >15 ×10^9/л	50% / 38% / 12%	12% / 29% / 59%
СРБ <15 / 15–60 / ≥60 мг/л	33% / 50% / 17%	14% / 36% / 50%
ПКТ <0,5 / 0,5–2 / 2–10 нг/мл	58% / 38% / 4%	4% / 32% / 64%

Пороги для гнойного отита: лейкоциты >15×10^9/л — ППР 85%, ПОР 64%; СРБ >30 мг/л — ППР 79%, ПОР 52%; ПКТ >2 нг/мл — ППР 94%, ПОР 74%. Таблица в PDF — изображение; значения перенесены вручную и сверены по изображению страницы 13.

Гнойное отделяемое отправляют на посев с определением чувствительности, если проводят парацентез или есть отделяемое из барабанной полости, а также в стационаре при тяжёлом и рецидивирующем отите.

КТ височных костей нужна при затяжном течении (дольше 10 дней), выраженном ухудшении и при подозрении на мастоидит или внутричерепные осложнения.

Если КТ сделать нельзя, при тех же показаниях делают рентгенографию височных костей по Шюллеру и Майеру.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Боль и температура

При боли и лихорадке назначают НПВП или парацетамол. Их дают разово: при боли в ухе или температуре выше 38,5 °C, а если в анамнезе были фебрильные судороги — уже при 38,0 °C.

Детям до 6 лет можно только парацетамол — до 60 мг/кг в сутки (10–15 мг/кг на приём) — или ибупрофен — до 30 мг/кг в сутки (8–10 мг/кг на приём).

Для местного обезболивания назначают ушные капли с лидокаином и феназоном, но только если барабанная перепонка цела.

4.2 Когда нужен антибиотик

Системные антибиотики назначают при наличии показаний.

Показание	Когда
Возраст до 2 лет	Во всех случаях при клинических признаках ОСО
Гнойная форма — в любом возрасте	Перфорация с гнойным отделяемым; или без перфорации — боль, не снимаемая анальгетиками, с выраженной гиперемией, отсутствием опознавательных знаков, выбуханием перепонки
Симптомы дольше 72 часов — в любом возрасте	Боль, лихорадка или интоксикация при отоскопических признаках ОСО 72 часа и более от начала
Рецидивирующее течение	3 и более эпизода за 6 месяцев или 4 и более за год

Показание	Когда
Сопутствующая патология	Сахарный диабет, иммунодефицит, муковисцидоз, синдромы цилиарной дискинезии, синдром Дауна, врождённые аномалии твёрдого и мягкого нёба
Нельзя повторно осмотреть	Нет возможности контрольного осмотра с отоскопией у ЛОР-врача или врача общей практики

4.3 Выбор антибиотика

Препарат первой линии — амоксициллин, если пациент не принимал его последние 30 дней, у него нет гнойного конъюнктивита и непереносимости аминопенициллинов.

Вторая линия — защищённые пенициллины или цефалоспорины III поколения. Если за 3 дня амоксициллин не помог, его меняют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим.

При затянувшемся и рецидивирующем отите сразу начинают с амоксициллина с клавулановой кислотой или цефиксима внутрь.

Макролиды у детей — третья линия, и только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов, потому что устойчивость пневмококка к ним выше 40%.

При лёгкой непереносимости пенициллинов назначают цефалоспорины III поколения: амбулаторно цефиксим, в стационаре при необходимости цефтриаксон парентерально.

Курс длится 7–10 дней. Дольше лечат детей до 2 лет, пациентов с отореей и сопутствующими болезнями; при затянувшемся и рецидивирующем отите курс обычно не меньше 14 дней. Антибиотик не отменяют, пока не прекратилась оторея.

Тетрациклины, линкозамиды, аминогликозиды и ко-тримоксазол не применяют: они плохо действуют на пневмококк и гемофильную палочку и дают много побочных эффектов.

В постперфоративной стадии системные антибиотики продолжают.

4.4 Суточные дозы

Препарат	Взрослые	Дети
Препарат выбора		
Амоксициллин (независимо от еды)	0,5 г × 3 р/сут без факторов риска[1]; 1,0 г × 3 р/сут при факторах риска[2]	50–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма[1]
Альтернативные препараты		
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[3] (в начале еды)	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут	40–45 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в[4]	3,6 г/сут в 3 введения	90 мг/кг/сут в 3 введения (4–40 кг); 60 мг/кг/сут (менее 4 кг)
Ампициллин + сульбактам в/в[3]	1,5–3 г/сут на 4 введения	150–300 мг/кг/сут на 3–4 введения
Цефтриаксон[4]	2,0–4,0 г/сут в 1 введение	50–80 мг/кг/сут в 1 введение
Аллергия на пенициллины (не анафилактическая)		

Препарат	Взрослые	Дети
Цефуроксим (сразу после еды)	500 мг/сут в 2 приёма (так в таблице КР)	до 3 лет: 30 мг/кг/сут в 2 приёма; старше 3 лет: 500 мг/сут на 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1 приём	8 мг/кг/сут в 1 приём
Аллергия на пенициллины и цефалоспорины		
Кларитромицин внутрь (показание «острый средний отит» зарегистрировано только для гранул для суспензии 125 и 250 мг/5 мл)	1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма

[1] [2] Без / при факторах риска устойчивости пневмококка: антибиотики за предшествующие 3 месяца; дети-дошкольники в семье, посещающие детские учреждения; проживание в «закрытых» учреждениях. [3] Факторы риска β-лактамаз: сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит), иммуносупрессия, неудача терапии амоксициллином. [4] При высоком риске осложнений.

> Внутри КР есть расхождение. В комментарии к рекомендации об амоксициллине обычная доза для детей — 45–60 мг/кг в сутки, а при высоком риске устойчивого пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки, тогда как в таблице 4 для детей указано 50–60 мг/кг в сутки.

Детям до 3 лет амоксициллин дают только в виде суспензии или диспергируемых таблеток. Амоксициллин с клавулановой кислотой и цефиксим в таблетках и капсулах разрешены с 12 лет; детям младше 12 лет с массой меньше 40 кг назначают гранулы, порошок для суспензии или диспергируемые таблетки.

4.5 Местная и вспомогательная терапия

При перфорации назначают ушные капли с фторхинолонами или с дексаметазоном в комбинации с противомикробными средствами, чтобы оторея прекратилась быстрее. Капли с аминогликозидами и спиртом нельзя: они ототоксичны.

Норфлоксацин разрешён детям старше 1 года, ципрофлоксацин — с 15 лет. Офлоксацин и дексаметазон с противомикробными средствами можно детям старше 1 года при остром гнойном отите и установленной тимпаностомической трубке.

Сосудосуживающие капли в нос назначают во всех стадиях, чтобы восстановить проходимость слуховой трубы, но не дольше 5–7 дней. Нафазолин не применяют.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет). До года — только капли, после года по возможности дозированный спрей.

Детям промывают нос изотоническим раствором морской воды 1–2 раза в день. Дошкольникам большие объёмы не используют, потому что это повышает риск отита.

Муколитики можно детям старше 2 лет. Показания проверяют по инструкции: не каждый муколитик для бронхов подходит при отите.

4.6 Хирургия

Парацентез делают при выраженных симптомах и выбухании перепонки без перфорации, при боли, которую не снимают НПВП, и если через 48–72 часа приёма антибиотиков нет улучшения. В сомнительных случаях решают в пользу парацентеза.

При внутривисочных или внутричерепных осложнениях проводят экстренную антромастоидотомию.

5. После острого периода и госпитализация

разделы 4–6 текста КР

Через 3–4 недели оториноларинголог повторно осматривает пациента с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы исключить экссудативный средний отит.

Если после отита пациент жалуется на снижение слуха, его направляют к сурдологу-оториноларингологу.

В репаративной стадии продувают слуховые трубы и делают пневмомассаж барабанных перепонок. То, что аэрация восстановилась, подтверждают объективно, в том числе тимпанометрией.

В репаративной стадии пациента консультирует физиотерапевт.

Всех детей прививают от пневмококковой инфекции по национальному календарю.

При рецидивирующем отите планово шунтируют барабанную полость (тимпаностомия).

Экстренно госпитализируют при тяжёлом течении, при лёгком течении без улучшения на адекватном лечении за 3–5 дней и при прогрессирующем ухудшении в любой момент.

Выписывают, когда состояние стабильно удовлетворительное не меньше 3 дней.

Отит тяжелее протекает и чаще осложняется при иммунодефиците и сахарном диабете. Чаще болеют пациенты с ГЭРБ, аллергическим ринитом и курильщики, в том числе пассивные.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Отит средний острый»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	314_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Детская доза амоксициллина: в комментарии к рекомендации — 45–60 мг/кг/сут («стандартная») и 80–90 мг/кг/сут (при высоком риске устойчивого пневмококка), в таблице 4 — 50–60 мг/кг/сут.
- Цефуроксим взрослым в таблице 4 — «500 мг/сут в 2 приёма»; проверьте по инструкции в ГРЛС.
- У ушных капель с офлоксацином в одном месте указан код АТХ S01AX13 (ципрофлоксацин), выше по тексту у офлоксацина — S01AX11.
- Таблица 2 (маркеры бактериального воспаления) в PDF вставлена изображением — её значения перенесены вручную.
- Капли с норфлоксацином: здесь — детям старше 1 года, в КР «Наружные отиты» (663_2) — с 15 лет. Проверьте по инструкции в ГРЛС.